

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN PREEKLAMPSIA BERAT (PEB) DAN EKLAMPSIA		
	No. Dokumen 571.14/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 Juli 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Penatalaksanaan yang dilakukan pada penderita PEB/Eklampsia dengan sindroma spesifik yang terjadi pada kehamilan di atas 20 minggu ditandai dengan oedem, tekanan darah $\geq 160/110$ mmHg, protein urin 2.0 gr/24 jam (albumin > 2+), serum kreatinin > 1,2 kecuali sebelumnya sudah diketahui meningkat, trombosit < 100.000/mm3, hemolisis mikrongiopati (peningkatan LDH), peningkatan SGOT dan SGPT, sakit kepala menetap atau gangguan serebral atau gangguan visus, nyeri ulu hati serta eklampsi terjadi kejang yang tidak disebabkan oleh sebab lain pada wanita hamil.		
Tujuan	1. Sebagai acuan penatalaksanaan pada penderita PEB dan Eklampsia guna mencegah komplikasi yang dapat timbul 2. Mencegah kejang 3. Mengatasi tekanan darah tinggi 4. Menyelamatkan ibu dan janin 5. Agar tindakan yang dilakukan berjalan efektif, efisien, konsisten dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standart yang berlaku		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman PONEK 24 jam 2. Dilakukan oleh Dokter.		
Prosedur	1. Siapkan alat 1) Siapkan alat-alat: a) Tensimeter, thermometer b) Funandoskop / dopller c) Patella hammer d) Resusitasi set e) Botol untuk pemeriksaan laboratorium darah, urine. f) Suction ukuran dewasa g) Obat obatan yang diperlukan (SM, antibiotik, cairan infus RD , infus set, DC set) 2) Dekatkan alat disamping pasien 2. Siapkan pasien a) Lakukan tindakan dengan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, santun)		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN PREEKLAMPSIA BERAT (PEB) DAN EKLAMPSIA		
	No. Dokumen 571.14/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 3
Prosedur	b) Perkenalkan diri pada pasien c) Identifikasi pasien (nama , register , tanggal lahir) d) Jelaskan pada ibu tujuan dan prosedur yang akan dilakukan 3. Siapkan lingkungan 3.1 Tempatkan pasien di ruangan khusus PEB		
	4. Siapkan petugas Cuci tangan 6 langkah 5. Lakukan penatalaksanaan kejang 1) Prosedur penanganan kejang 1. Beri obat anti kejang , 2. Siapkan perlengkapan untuk penanganan anti kejang 3. Lindungi pasien dari kemungkinan trauma 4. Aspirasi mulut dan tenggorokan 5. Baringkan pasien pada sisi kiri, posisi Trandelenburg untuk mengurangi resiko aspirasi 6. Beri 02 4-6 liter/detik 2) Penanganan umum 1. Jika tekanan diagnostik > 110 mmHg, berikan antihipertensi, sampai tekanan diagnostik di antara 90-100 mmHg. 2. Pasang infus RD5 dengan jarum besar (16 gauge atau >). 3. Ukur keseimbangan cairan, jangan sampai terjadi overload. 4. Kateterisasi urine untuk pengukuran pemeriksaan volume dan proteinuria. 5. Jika jumlah urine < 30 ml per jam: ➤ Infus cairan dipertahankan 1 liter / 8 jam ➤ Pantau kemungkinan edema paru 6. Jangan tinggalkan pasien sendirian. Kejang disertai aspirasi dapat mengakibatkan kematian ibu dan janin. 7. Observasi tanda-tanda vital, reflek dan denyut jantung janin setiap jam 8. Auskultasi paru untuk mencari tanda-tanda edema paru, krepitasi merupakan tanda edema paru. Jika ada edema paru, stop pemberian cairan dan berikan diuretik misalnya furosemide 40 mg iv. 9. Nilai pembekuan darah dengan uji pembekuan bedside. Jika pembekuan tidak terjadi sesudah 7 menit, kemungkinan terdapat koagulopati 6. Rapikan pasien dan bereskan alat 1. Rapikan pasien dengan posisi yang nyaman 2. Cuci tangan 6 langkah 7. Lakukan evaluasi dan dokumentasi perkembangan		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN PREEKLAMPSIA BERAT (PEB) DAN EKLAMPSIA		
	No. Dokumen 571.14/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 3 / 3
	pasien 1. Amati dan catat hasil tindakan 2. Evaluasi hasil tindakan dan respon pasien		
Unit Terkait	1. IGD 2. Ruang bersalin Kandungan & Kebidanan 3. RR		